PROPUESTA INSTITUCIONAL · DOCUMENTO TÉCNICO

Estrategias viables para reducir las cesáreas sin indicación y favorecer el parto eutócico en los hospitales públicos de la Ciudad de México

Revisión de la evidencia, marco normativo y bioético, formación de recursos humanos y diseño de un plan de implementación para SEDESA/IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE e institutos nacionales

Versión 1.0 · noviembre de 2026 · Citas en estilo Vancouver · Documento elaborado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas; ver «Método y limitaciones»

Resumen ejecutivo

Problema. México está entre los países con más cesáreas del mundo. Las estadísticas vitales muestran un aumento del 43.9 % en 2008 al 45.5 % en 2017 [1]. La ENADID 2023 indica que 51 de cada 100 partos recientes fueron por cesárea [2]. Análisis más recientes de los certificados de nacimiento sitúan la proporción entre el 53.8 % y el 55 % en 2023 [3,4]. La OMS no fija una tasa ideal por hospital. Sí establece que, a nivel poblacional, tasas superiores al 10 % no se asocian con menor mortalidad materna ni neonatal [5]. La cesárea sin indicación aumenta la morbilidad materna, el riesgo de placentación anormal y rotura uterina en embarazos posteriores, y se asocia con alteraciones inmunitarias y metabólicas en la descendencia [6].

Situación en la CDMX. La red de SEDESA atendió 24,347 nacimientos en 2022, con 9,197 cesáreas (≈37.8 %) [7]. Los hospitales de seguridad social y los de tercer nivel registran proporciones mucho mayores: el ISSSTE el 72.1 % a nivel nacional, y el CMN La Raza el 76.1 %, según un análisis periodístico de datos de la DGIS [3]. Las comparaciones crudas engañan porque la complejidad de cada hospital es distinta. Por eso la herramienta de medición recomendada es la clasificación de Robson [5,8].

Qué funciona (evidencia más sólida).

1. Guías clínicas combinadas con auditoría de cesáreas y retroalimentación oportuna. La OMS las recomienda con certeza alta [9]. En el ensayo QUARISMA lograron una reducción pequeña pero significativa, con mejores resultados neonatales [10].
2. Segunda opinión obligatoria antes de una cesárea no urgente. Un ensayo hecho en Latinoamérica, con hospitales mexicanos, la redujo en un 7.3 % relativo sin afectar la seguridad [11].
3. Acompañamiento continuo durante el trabajo de parto, con RR de cesárea de 0.75 [12].
4. Modelos de continuidad con partería o enfermería obstétrica, con RR de 0.91 y más parto vaginal espontáneo [13].
5. Criterios modernos de trabajo de parto: fase activa desde 5–6 cm y segundo periodo sin límites arbitrarios [14–16].
6. Auscultación intermitente en bajo riesgo, en lugar de cardiotocografía continua rutinaria [17].
7. Versión cefálica externa [18] y prueba de trabajo de parto después de una cesárea, en candidatas adecuadas [19].
8. Colaboración entre hospitales, con medición pública y paquetes de cambio [20,21].

Propuesta. Un programa interinstitucional en tres fases, con duración de 36 meses: diagnóstico, piloto y escalamiento. Se organiza en diez componentes y su eje es la auditoría Robson mensual con retroalimentación. Las metas se fijan por grupo de Robson, sobre todo los grupos 1, 2 y 5, y no como una cifra global. Cada indicador de reducción se acompaña de indicadores de seguridad (de balance). El diseño de evaluación es escalonado (*stepped-wedge*). La propuesta se apoya en normatividad vigente: NOM-007-SSA2-2016 [22], las GPC de reducción de cesárea y de atención amigable del parto [23,24], la reforma en materia de partería de 2024 y la NOM-020-SSA-2025 [25,26]. Responde además a las obligaciones de derechos humanos sobre violencia obstétrica [27,28]. La viabilidad se considera **alta** para los componentes de gestión clínica y auditoría. Es **media** para la partería integrada, porque depende de plazas, y **baja a media** para los incentivos financieros en el sector público.

1. Alcance, método y limitaciones

Alcance. El documento cubre hospitales públicos que atienden partos en la CDMX: la red de SEDESA, hoy en coordinación operativa con IMSS-Bienestar; los hospitales del IMSS ordinario y del ISSSTE; y los institutos y hos-

pitales federales de referencia, como el INPer. Incluye la evidencia clínica y no clínica, la epidemiología, la normatividad, la bioética, la formación de recursos humanos, la economía y la ciencia de la implementación.

Método. Se hizo una revisión narrativa estructurada de documentos rectores de la OMS, FIGO y ACOG; revisiones sistemáticas Cochrane; ensayos aleatorizados por conglomerados; estudios poblacionales mexicanos (DGIS/SINAC, ENADID, ENSANUT, ENDIREH); normas oficiales mexicanas, leyes y guías de práctica clínica; e informes de organismos de derechos humanos. Se priorizaron fuentes primarias y revisadas por pares.

Limitaciones (lectura obligatoria).

1. Durante la elaboración no fue posible abrir el texto completo de varias fuentes. Las cifras se tomaron de resúmenes oficiales, registros bibliográficos o comunicados institucionales.
2. Algunas cifras recientes por institución provienen de fuentes periodísticas que analizan bases de la DGIS y se señalan como «secundarias». Deben verificarse en los cubos dinámicos del SINAC antes de usarse como línea base oficial.
3. No se encontró una serie oficial publicada de la tasa de cesáreas por institución *dentro* de la CDMX. Por eso la Fase 0 del plan incluye construirla.
4. Ninguna cifra de este documento se estimó ni se imputó sin fuente. Los cálculos derivados, como porcentajes a partir de cifras absolutas, se marcan como tales.

2. Marco conceptual

Parto eutócico es el que evoluciona de forma fisiológica, con inicio espontáneo y feto único en presentación cefálica. Termina por vía vaginal sin necesidad de intervención instrumental. **Distocia** es cualquier alteración de la evolución normal. La **cesárea** es la extracción fetal por laparotomía e histerotomía. Puede ser electiva (programada) o intraparto (de urgencia). La «reducción de cesáreas» que busca este documento se refiere a las cesáreas *no necesarias desde el punto de vista médico*. Debe garantizarse a la vez el acceso oportuno a la cesárea indicada, porque tanto el exceso como la falta de cesáreas causan daño [29,30].

Tasa de referencia. Desde 1985 circuló el rango ideal de 10–15 %. La Declaración de la OMS de 2015 concluye que, a nivel poblacional, la mortalidad materna y neonatal desciende al aumentar la tasa hasta cerca del 10 %, y que por encima de ese valor no hay beneficio adicional. La OMS *no* recomienda una tasa específica para hospitales, porque esta depende de la población atendida. En su lugar propone la clasificación de Robson como estándar mundial para monitorear y comparar [5].

Clasificación de Robson. Asigna a cada mujer que da a luz a uno de 10 grupos mutuamente excluyentes. Usa cinco parámetros obstétricos: antecedentes obstétricos (paridad y cesárea previa), inicio del trabajo de parto, edad gestacional, presentación o situación fetal, y número de fetos. Permite identificar qué grupos generan la tasa global y compararlos entre hospitales y en el tiempo [8]. Para fines de reducción, los grupos más relevantes son:

- **Grupo 1:** nulípara, término, cefálico, inicio espontáneo.
- **Grupo 2:** nulípara inducida (2a) o con cesárea antes del trabajo de parto (2b).
- **Grupo 5:** cesárea previa, término, cefálico.

Las cesáreas evitadas en los grupos 1 y 2 previenen la acumulación futura en el grupo 5. En un análisis de la OMS en 21 países, la tasa global subió del 26.4 % al 31.2 %. En los países de desarrollo humano medio o bajo, la cesárea previa resultó un determinante cada vez más importante [31].

3. Epidemiología

3.1 Contexto mundial y regional

Con datos de 154 países (2010–2018), el 21.1 % de los nacimientos en el mundo fue por cesárea. América Latina y el Caribe tienen la tasa regional más alta, con 42.8 %. Se proyecta que la cifra mundial llegue al 28.5 % en 2030, con sobreuso y falta de acceso conviviendo al mismo tiempo [29]. Entre 2000 y 2015 la proporción mundial casi se duplicó, del 12 % al 21 % [32].

3.2 México

Indicador	Valor	Fuente y observaciones
Cesáreas en 1999 (nacional)	>35 %; privado 53 %	Puentes-Rosas et al. Crecimiento de ≈1 % anual en la década previa [33].
Exceso de cesáreas en instituciones públicas, 1993–97	Cuantificado sobre el umbral de 15 %	Se calificó como problema de salud pública no atendido por las autoridades [34].

Indicador	Valor	Fuente y observaciones
Cesáreas 2000→2012 (ENSANUT)	Público 30.6→40.9 %; privado 43.4→69.6 %	Aumento nacional de 30.0 % a 45.1 % entre 2000 y 2012 [35].
Certificados de nacimiento 2008→2017	43.9 %→45.5 %	De 869,018 de 1,978,380 nacimientos a 940,206 de 2,064,507. El mayor cambio ocurrió en el sector privado. Descenso leve en todos los sectores desde 2014 [1].
ENADID 2023 (último embarazo, 2018–2023)	51 de cada 100 partos	De las cesáreas, 56.1 % fueron programadas y 43.9 % de urgencia [2].
DGIS 2014→2023 (todas las instituciones)	46.6 %→53.8 %	Sector público 42.3 %; PEMEX 79.5 %; ISSSTE 72.1 %; SEMAR 63.7 %. *Fuente secundaria* [3].
INSP, 2010→2023	45 %→55 %	Estudio sobre el efecto del exceso de cesáreas en la edad gestacional al nacer. Difusión institucional [4].
Sector privado 2023	277,426 cesáreas	Equivalen al 20 % de todos los procedimientos quirúrgicos en establecimientos particulares [36].
Nacimientos registrados 2023	1,820,888	Descenso del 3.7 % respecto a 2022 [37].

La discrepancia entre fuentes (51 %, 53.8 %, 55 %) se explica por diferencias de denominador, periodo y fuente: encuesta frente a registro. En cualquier caso, la tendencia es al alza tras una breve meseta entre 2014 y 2017. En la serie 2008–2017, la institución de atención fue el factor con mayor fuerza de asociación con la cesárea [1]. Un análisis de 2011–2014 encontró mayor probabilidad de cesárea con mayor escolaridad. También observó un incremento de cesáreas en hospitales públicos después del aseguramiento del Seguro Popular [38].

3.3 Ciudad de México

Unidad o red	Dato	Fuente
Red SEDESA (34 hospitales), 2022	24,347 nacimientos; 9,197 cesáreas (≈37.8 %, cálculo propio)	Comunicado del Gobierno de la CDMX [7]
Red SEDESA, enero–marzo de 2024	5,721 nacimientos; 2,231 cesáreas (≈39 %, cálculo propio)	Comunicados SEDESA/IMSS-Bienestar [39]
Hospital Materno Infantil Inguarán, 2022	3,690 nacimientos (mayor volumen de la red)	[39]
CMN La Raza (IMSS, tercer nivel)	76.1 % de cesáreas	Fuente secundaria con datos DGIS [3]
CIMIGen (primer nivel, privado no lucrativo, CDMX)	39.9 %	Los grupos de Robson que más contribuyen son el 1 (17.6 %), el 2a (19.4 %), el 2b (17.2 %) y el 5.1 (22.9 %) [40]
Fecundidad CDMX 2023	34.1 nacimientos por 1,000 mujeres en edad fértil (de las más bajas del país)	[37]

Estos datos sugieren un gradiente esperable. Los hospitales generales y materno-infantiles de SEDESA, que atienden sobre todo población de bajo riesgo sin seguridad social, tienen tasas cercanas al 38–39 %. Los hospitales de referencia de alta complejidad superan el 70 %. Las cifras no son comparables mientras no se ajusten por Robson. Sin embargo, incluso con ajuste, el 38 % en hospitales generales es muy superior al rango poblacional que la OMS asocia con beneficio [5]. Estudios mexicanos con Robson muestran que los grupos 1, 2 y 5 son contribuyentes principales y modificables [40].

4. Determinantes del exceso de cesáreas

Nivel	Determinantes documentados	Fuentes
Clínico	Cesárea previa (efecto acumulativo hacia el grupo 5); diagnóstico precoz de «falta de progreso» antes de la fase activa real; inducciones con cérvix desfavorable; cardiotocografía continua rutinaria, que aumenta las cesáreas sin reducir la mortalidad perinatal; menor práctica de parto instrumentado, versión cefálica externa y parto pélvico.	14,17,30,31

Nivel	Determinantes documentados	Fuentes
Organizacional	Saturación de salas de labor; falta de acompañante; modelos centrados en el médico sin enfermería obstétrica ni partería; turnos con residentes sin supervisión suficiente; ausencia de auditoría y de liderazgo clínico.	9,30,39
Médico-legal	Temor a demandas y quejas. Embarazo, parto y puerperio fue el principal diagnóstico que originó quejas ante la CONAMED entre 2001 y 2015 (24,393 quejas en total).	30,41
Económico	Incentivos por honorarios o por paquetes en el sector privado, que influyen en la práctica dual de médicos que también laboran en el sector público; programación de agendas; aumento asociado al esquema de aseguramiento público.	1,30,38
Sociocultural	Miedo al dolor y al parto; experiencias previas negativas o de maltrato; percepción de que la cesárea es más segura; información prenatal insuficiente.	9,30
Derechos humanos	Cesáreas sin consentimiento: 9.1 % de las mujeres con cesárea en la ENDIREH 2016. La probabilidad es mayor con control prenatal privado o mixto. Entre 2016 y 2021 disminuyó a nivel nacional.	42,43

5. Consecuencias de la cesárea no indicada

Maternas. La mortalidad y la morbilidad maternas son mayores tras la cesárea que tras el parto vaginal. En embarazos posteriores aumentan, con relación dosis-respuesta, la rotura uterina, la placentación anormal (previa y espectro de acretismo), el embarazo ectópico, la muerte fetal y el parto pretérmino [6]. El riesgo de placenta previa, de acretismo y de histerectomía obstétrica crece con cada cesárea adicional [44].

México. Se analizaron 4,561 muertes maternas entre 2010 y 2014. El 47.1 % de ellas había tenido cesárea. Entre esas mujeres, el 31.4 % tenía una cesárea previa, frente al 17.4 % de quienes tuvieron parto vaginal (OR 2.38). Hubo además asociación con muertes por trastornos hipertensivos. Los autores advierten que son asociaciones y no prueban causalidad [45]. La razón de mortalidad materna nacional preliminar fue de 22.6 por 100,000 nacimientos estimados a la semana 18 de 2024 [46].

Neonatales e infantiles. A corto plazo hay alteraciones en el desarrollo inmunitario y menor diversidad del microbioma. A más largo plazo se han reportado asociaciones con alergia, asma y obesidad infantil, aunque la evidencia es menos robusta [6]. El INSP estudió el efecto del exceso de cesáreas sobre la edad gestacional al nacer en México [4].

Económicas. En 2008 se estimaron 6.2 millones de cesáreas innecesarias en el mundo, con un costo marginal de ≈US$2,320 millones. Las cesáreas necesarias que faltaban (3.18 millones) habrían costado ≈US$432 millones. Es decir, el sobreuso absorbe recursos que podrían cubrir la falta de acceso [47]. Como referencia nacional, el tabulador del IMSS para no derechohabientes fijó en 2023 un paquete de cesárea con recién nacido sano de $23,986.20, con dos días de estancia, y un costo de $11,919 por día adicional de hospitalización [48]. Son tarifas, no costos de oportunidad. Una evaluación económica local debe usar los costos unitarios de cada institución. En QUARISMA, la intervención se asoció con ahorros importantes [10].

6. Marco normativo y de política pública

Instrumento	Contenido relevante para la estrategia
Ley General de Salud. Reforma en materia de partería (DOF 26-03-2024)	Reconoce y protege la partería tradicional (art. 64 fr. IV, 79, 389 Bis, 392, entre otros). Para la partería profesional exige título o certificado registrado [25].
NOM-007-SSA2-2016	Regula la atención del embarazo, parto y puerperio. Define el partograma como herramienta fundamental de llenado rutinario (3.32). Exige abrir el expediente al ingreso (5.5) y registrar el resultado del parto (5.5.20) [22]. Da sustento a protocolos de vigilancia del trabajo de parto y a la auditoría.
NOM-004-SSA3-2012 (expediente clínico)	Exige carta de consentimiento informado para ingreso hospitalario, cirugía mayor y procedimientos con anestesia general o regional (10.1.2) [49]. Base para el consentimiento de la cesárea y para la segunda opinión documentada.
NOM-020-SSA-2025 (partería)	Publicada el 04-03-2025 y vigente desde el 31-08-2025. Reconoce la partería profesional y tradicional en la atención materna y neonatal. Hay controversia y amparos de parteras tradicionales por los requisitos de certificación [26].
Comité Nacional de Partería (DOF 01-05-2026)	Espacio de coordinación con participación de IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar e INPer, entre otros [50].

Instrumento	Contenido relevante para la estrategia
GPC IMSS-048-08 «Reducción de la frecuencia de operación cesárea»	Criterios de indicación y de prueba de trabajo de parto después de cesárea. Contraindicaciones: incisión clásica, en T o transfúndica, y rotura uterina previa. Uso cauteloso de oxitocina con monitoreo; analgesia epidural permitida [23].
GPC-IMSS-052-19 «Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto»	Marco para la atención respetuosa y basada en evidencia del parto de bajo riesgo [24].
Modelo de atención con enfoque humanizado, intercultural y seguro (SSA)	Nombre definido en 2012 por el CNEGSR y la DGPLADES. Cuenta con lineamientos e indicadores de implantación, manejo no farmacológico del dolor y competencias interculturales [51].
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, art. 6 fr. VII	Tipifica la violencia obstétrica como modalidad de violencia, con reformas en la Gaceta Oficial (2022 y posteriores) [28]. Según la CDHCM, la CDMX es la segunda entidad con mayor incidencia de violencia obstétrica [52].
CNDH, Recomendación General 31/2017	Define la violencia obstétrica como violencia institucional y de género, y formula recomendaciones al Sistema Nacional de Salud [27].
Instrumentos internacionales	Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea [5]. Recomendaciones de la OMS sobre intervenciones no clínicas [9] y sobre atención intraparto para una experiencia positiva [15]. Declaraciones de FIGO [53,54].

Implicación. No hace falta crear normas nuevas para la mayoría de los componentes del plan. El reto es de *cumplimiento* y de gestión. Puede emitirse un lineamiento interinstitucional de la CDMX que haga operativos la auditoría Robson, la segunda opinión y los criterios de trabajo de parto, con fundamento en las NOM y GPC vigentes.

7. Dimensión bioética y de derechos humanos

El análisis se basa en los cuatro principios de la bioética biomédica [55] y en el enfoque de derechos humanos [27].

- **No maleficencia y beneficencia.** Una cesárea sin indicación expone a la mujer y a su descendencia a riesgos sin beneficio clínico demostrado [6]. Para FIGO, la cesárea por razones no médicas no está éticamente justificada [54]. Por la misma razón, reducir cesáreas nunca debe retrasar una cesárea indicada. De ahí la necesidad de indicadores de balance.
- **Autonomía.** La cesárea a solicitud materna exige consejería sobre riesgos y beneficios. Explorar el miedo al parto y ofrecer apoyo puede resolver muchas solicitudes. Si se mantiene la decisión, ACOG recomienda no realizarla antes de las 39 semanas e informar que los riesgos aumentan con cada cesárea [44]. FIGO pide que la mujer tenga información actualizada, completa y comprensible [53]. La autonomía también protege contra la cesárea no consentida (9.1 % en la ENDIREH 2016) [42]. Realizar una cesárea sin consentimiento, existiendo condiciones para el parto vaginal, es una de las conductas que la legislación sobre violencia obstétrica busca sancionar [28].
- **Justicia.** En el mundo, el sobreuso coexiste con la falta de acceso [29], y el gasto en cesáreas innecesarias desplaza recursos [47]. Una estrategia justa reduce lo innecesario sin crear barreras para mujeres indígenas, adolescentes o en situación de pobreza.
- **Decisión compartida.** Se recomienda el modelo de tres pasos: presentar las opciones, deliberar y decidir [56]. Se apoya con ayudas de decisión para la prueba de trabajo de parto después de cesárea, la versión cefálica externa y la inducción.
- **Tensiones éticas del propio plan.**
  1. Las metas numéricas pueden presionar al personal a negar cesáreas indicadas. Se mitiga con metas por grupo de Robson y con vigilancia de resultados adversos.
  2. La segunda opinión puede percibirse como desconfianza hacia el médico tratante. Se mitiga con un enfoque formativo, no punitivo.
  3. La auditoría puede vulnerar la confidencialidad del personal. Se mitiga con análisis agregado y cultura justa.

8. Formación de recursos humanos: planes de estudio

Medicina (pregrado). En el Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ginecología y Obstetricia es una asignatura clínica de 4.º año (8.º semestre). El internado médico de pregrado corresponde al 5.º año [57]. El plan está orientado a competencias, pero no se localizó un estándar curricular nacional de habilidades mínimas en atención del parto vaginal.

Especialidad. La residencia de Ginecología y Obstetricia dura cuatro años y en las sedes de la CDMX tiene aval de la UNAM conforme al Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM) [58]. En la literatura internacional se

documenta una disminución del volumen de partos instrumentados (fórceps y vacuum) durante la residencia, con aumento simultáneo de cesáreas. La enseñanza basada en simulación mejora la competencia técnica y la confianza con fórceps [59]. Betrán et al. señalan la capacitación profesional como palanca clave para hacer posible el parto vaginal: parto instrumentado, versión cefálica externa, parto pélvico seleccionado y parto después de cesárea [30].

Enfermería obstétrica y partería. La ENEO-UNAM imparte la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, cuyo plan se encontraba en proceso de modificación en 2022 [60]. El IPN cuenta con su Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. La oferta de partería profesional en el país es escasa. La reforma de 2024 y la NOM-020-SSA-2025 abren un marco legal para integrarla [25,26]. Según información institucional difundida en 2026, la estrategia nacional contempla 5,161 plazas para parteras en el sistema público, y el IMSS reporta 2,930 matronas colaborando en 18 representaciones [61]. En 2022, 402 profesionales de obstetricia (enfermería obstétrica y partería) trabajaban en 19 hospitales de la CDMX y contribuyeron a más de 16,000 nacimientos [39].

Propuestas curriculares derivadas:

1. Un módulo obligatorio de Robson, fisiología del trabajo de parto y criterios OMS/ACOG en pregrado e internado.
2. Simulación con evaluación OSCE de parto eutócico, distocia de hombros, parto instrumentado, parto pélvico y versión cefálica externa.
3. Rotación de residentes por unidades de partería o de labor-parto-recuperación.
4. Formación en comunicación, consentimiento y decisión compartida.
5. Educación interprofesional médico–enfermería obstétrica–partería.
6. Educación médica continua acreditada para adscritos en vigilancia del trabajo de parto y auscultación intermitente.

9. Evidencia sobre intervenciones

9.1 Intervenciones no clínicas (organizacionales, de política y dirigidas a profesionales o usuarias)

Intervención	Efecto principal	Certeza / fuente
Guías clínicas + auditoría de cesáreas + retroalimentación oportuna	La OMS la recomienda. En la revisión Cochrane, la combinación de guías con auditoría redujo la cesárea en ≈1.8 puntos (DR −1.8 %; IC 95 % −3.8 a −0.2).	Alta [9,62]
QUARISMA (Quebec, 32 hospitales): capacitación + auditoría trimestral con análisis de cada cesárea	Cesárea 21.8 % en el grupo de intervención frente a 23.5 % en el control (p=0.04). Mayor efecto en bajo riesgo. Menos morbilidad neonatal menor y mayor. Hubo ahorros.	ECA por conglomerados [10]
Segunda opinión obligatoria antes de una cesárea no urgente	Reducción relativa del 7.3 % (IC 0.2–14.5) y del 12.6 % en cesáreas intraparto. Sin cambios en mortalidad perinatal ni en satisfacción. Incluyó 4 hospitales mexicanos. La opinión cambió la decisión inicial en solo ≈2 % de los casos: el efecto parece actuar por cambio de conducta.	ECA, 34 hospitales [11,62]
Educación prenatal y talleres de preparación para el parto en pareja	Los talleres podrían reducir la cesárea (RR 0.59; IC 0.37–0.94). La OMS los recomienda con monitoreo y evaluación.	Baja [9,62]
Modelo colaborativo partería–obstetricia	La OMS lo recomienda en el contexto de investigación rigurosa.	Baja [9]
Colaborativo estatal de calidad (CMQCC, California)	La cesárea NTSV bajó de 26.0 % a 22.8 % entre 2014 y 2019, mientras el resto de EE. UU. se mantuvo en 26.0 %. En los hospitales participantes bajó de 28.6 % a 24.2 %. Las complicaciones neonatales graves inesperadas bajaron de 2.1 % a 1.5 %. Es un estudio observacional.	[20]
Acción nacional concertada con capacitación y la tasa de cesárea como criterio de financiamiento (Portugal, 2010)	La tasa nacional bajó de 36.6 % a 33.1 %. Aumentaron el parto después de cesárea y el parto instrumentado; la mortalidad perinatal siguió descendiendo. La asociación es posible pero no causal.	Observacional [21]
Projeto Parto Adequado (Brasil, hospitales privados)	A mayor grado de implementación, mayor tasa de parto vaginal. La implementación fue baja en «reorganización de la atención» y en «participación de las mujeres».	[63]

Intervención	Efecto principal	Certeza / fuente
Paquetes de precio y subsidio al parto vaginal (Irán)	Efecto a corto plazo y no sostenido en algunas provincias. Las medidas de precio por sí solas no bastaron.	Series temporales [64]
Líderes de opinión, publicación de tasas, estrategias financieras, fijación de metas	Sin ensayos elegibles en la revisión Cochrane: es un vacío de evidencia.	[62]

9.2 Intervenciones clínicas

Intervención	Efecto principal	Fuente
Criterios actualizados de trabajo de parto	La fase activa inicia en 6 cm (ACOG/SMFM) o 5 cm (OMS). La detención en fase activa requiere ≥6 cm con membranas rotas, sin cambio tras 4 h de actividad adecuada o ≥6 h de oxitocina. En el segundo periodo, se deben permitir al menos 2 h de pujo en multíparas y 3 h en nulíparas, y puede ser más con analgesia regional. La Guía de Atención del Trabajo de Parto de la OMS sustituye la línea de alerta de 1 cm/h por límites de tiempo por centímetro.	[14–16]
Auscultación intermitente frente a cardiotocografía continua en bajo riesgo	La cardiotocografía continua aumenta las cesáreas (RR 1.63; IC 1.29–2.07) y reduce las convulsiones neonatales (RR 0.50), sin diferencia en mortalidad perinatal.	[17]
Acompañamiento continuo (familiar, doula o personal)	Cesárea RR 0.75 (IC 0.64–0.88; 24 ensayos, 15,347 mujeres). Menos parto instrumentado y menos Apgar bajo. El efecto fue mayor en países de ingreso medio.	[12]
Continuidad con partería	Cesárea RR 0.91 (IC 0.84–0.99), con certeza moderada. El parto vaginal espontáneo aumenta de 66 % a 70 %.	[13]
Unidades de partería contiguas al hospital (bajo riesgo)	Muchas menos cesáreas intraparto y más partos normales, sin diferencia en resultados perinatales adversos. En nulíparas, los traslados al área obstétrica fueron del 36–45 %.	[65]
Analgesia epidural	No aumenta la cesárea (RR 1.07; IC 0.96–1.18). Permite ofrecer alivio del dolor sin penalizar la vía vaginal.	[66]
Versión cefálica externa a término	Cesárea RR 0.57 (IC 0.40–0.82); presentación no cefálica al nacer RR 0.42.	[18]
Prueba de trabajo de parto después de cesárea (TOLAC)	Es una opción razonable con una cesárea previa segmentaria transversa. Éxito del 60–80 %. La rotura uterina ocurre en ≈0.5–0.9 %. Requiere capacidad de cesárea inmediata y consejería.	[19,23,67]
Inducción a las 39 semanas en nulíparas de bajo riesgo (ARRIVE)	Cesárea 18.6 % frente a 22.2 % con manejo expectante (RR 0.84). Implica mayor carga en las salas de labor. Su extrapolación a hospitales saturados es incierta.	[68]

> **Mensaje clave.** Los efectos aislados son modestos, del 1 al 4 % absoluto. Betrán et al. concluyen que las intervenciones deben ser *multicomponente y adaptadas localmente*. Deben atender las preocupaciones de las mujeres y de los profesionales, así como los factores del sistema y los financieros [30].

10. Experiencias en México y la CDMX

- **IMSS, modelo AMIIMSS (desde marzo de 2022).** Es un decálogo que incluye parto vaginal, información sobre cesáreas, atención amigable y trato humano. El IMSS informa una reducción de 1 punto porcentual en la proporción de cesáreas, equivalente a ≈9,000 cesáreas menos al año. Opera en 92 hospitales. Son cifras autorreportadas, sin evaluación independiente publicada [69].
- **SEDESA/IMSS-Bienestar.** En febrero de 2023 abrió la primera Sala de Labor-Parto-Recuperación de la red, en el Hospital General Iztapalapa. Ofrece acompañante, libre elección de posición y analgesia no farmacológica; para mayo de 2024 se habían atendido 170 nacimientos. Hay partería profesional gratuita para embarazos de bajo riesgo y capacitación en trato digno, anunciada en noviembre de 2023 [39].
- **Ensayo de segunda opinión.** México participó con cuatro hospitales en el ensayo latinoamericano, lo que prueba que la intervención es factible en el contexto nacional [11].
- **Estudios con Robson en hospitales mexicanos.** Existen análisis en CIMIGen [40] y una tesis sobre el INPer (2009–2013). Muestran factibilidad y señalan los grupos 1, 2 y 5 como objetivos.

11. Análisis estratégico: opciones, pros, contras y viabilidad en la CDMX

Estrategia	Pros	Contras y riesgos	Costo	Viabilidad	Evidencia
Auditoría Robson mensual con retroalimentación	Barata. Recomendada por la OMS. Usa datos del expediente y del SINAC. Permite comparar instituciones.	Requiere capturistas o analistas y liderazgo. Puede percibirse como punitiva.	Bajo	**Alta**	Alta
Segunda opinión obligatoria (cesáreas no urgentes)	Probada en México. Segura.	Requiere un segundo médico disponible. Efecto modesto. Puede generar resistencia.	Bajo	**Alta** (turno con adscrito)	Moderada
Protocolo de trabajo de parto (5–6 cm; segundo periodo) y Guía de Atención del Trabajo de Parto de la OMS	Ataca la principal causa en el grupo 1. Respaldado por la GPC 052-19.	Mayor estancia en labor, lo que exige camas y personal. Cambio cultural.	Bajo-medio	**Alta**	Alta
Auscultación intermitente en bajo riesgo	Menos cesáreas. Requiere poca tecnología.	Requiere una proporción enfermera:mujer cercana a 1:1 o 1:2. Hay temor médico-legal.	Medio	Media	Alta
Acompañante de elección	Gran efecto. Costo marginal. Es un derecho.	Espacios abiertos sin privacidad. Barreras de control de infecciones.	Bajo	**Alta** (con adecuaciones)	Moderada
Enfermería obstétrica y partería en equipo (modelo colaborativo, salas LPR)	Más parto espontáneo. Libera tiempo médico. Hay respaldo normativo (2024–2025).	Plazas, tabuladores, definición de alcance, resistencia gremial y controversia por la NOM-020.	Medio-alto	Media	Moderada
Clínica de parto después de cesárea y de versión cefálica externa	Reduce el grupo 5 y la presentación pélvica (grupos 6 y 7).	Requiere quirófano y anestesia 24/7, consejería y competencias.	Medio	Media-alta (2.º–3.er nivel)	Moderada
Educación prenatal y ayudas de decisión	Atiende el miedo y la solicitud materna. Se integra al primer nivel.	Efecto incierto. Coordinación entre el primer nivel y los hospitales.	Bajo	Alta	Baja
Simulación y educación médica continua	Recupera habilidades (instrumentado, distocias).	Simuladores, tiempo protegido, acuerdos con universidades.	Medio	Alta	Moderada
Colaborativo interinstitucional y tablero público	Aprendizaje entre pares. Efecto en California y Portugal.	Fragmentación institucional. Sensibilidad política de publicar tasas.	Bajo-medio	Media	Observacional
Incentivos financieros por desempeño	Alinea la gestión con las metas.	Presupuesto público rígido. Riesgo de juego con los datos. Evidencia escasa.	Variable	Baja-media	Vacío
Inducción electiva a las 39 semanas	Puede reducir cesáreas en nulíparas.	Satura las salas de labor. Datos poblacionales contradictorios.	Medio	Baja (por saturación)	Alta (ECA)

11.1 Análisis FODA del programa

Fortalezas. Hay marco normativo vigente (NOM-007, GPC, reforma de partería). Existe una experiencia mexicana con segunda opinión y una red SEDESA con salas LPR y partería. El IMSS ya opera AMIIMSS. Las sedes formadoras están avaladas por la UNAM.

Oportunidades. Creación del Comité Nacional de Partería (2026). Integración de los servicios IMSS-Bienestar. Atención pública a la violencia obstétrica. Descenso de la natalidad en la CDMX, que reduce la carga asistencial. Herramientas de la OMS listas: Robson y la Guía de Atención del Trabajo de Parto.

Debilidades. Fragmentación entre instituciones con sistemas de información distintos. Saturación de hospitales de referencia. Escasez de plazas de enfermería obstétrica y partería. Dependencia de residentes en turnos nocturnos. Ausencia de una línea base Robson pública.

Amenazas. Temor médico-legal. Práctica dual público-privada. Resistencia gremial. Controversia sobre la NOM-020. Riesgo de que metas mal diseñadas retrasen cesáreas indicadas. Cambios administrativos que interrumpan la continuidad.

12. Diseño del plan de implementación

12.1 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general. Reducir las cesáreas sin indicación médica y aumentar el parto vaginal seguro y respetado en los hospitales públicos de la CDMX, sin deterioro de los resultados maternos y perinatales, en un plazo de 36 meses.

Objetivos específicos.

1. Medir con Robson el 100 % de los nacimientos en los hospitales participantes.
2. Reducir la tasa del grupo 1 y del grupo 2a.
3. Aumentar la proporción de TOLAC ofrecida y lograda en el grupo 5.
4. Garantizar acompañante de elección y consentimiento informado documentado.
5. Fortalecer las competencias del personal y la integración de la partería y la enfermería obstétrica.

> **Sobre las metas.** La OMS no fija tasas hospitalarias [5]. Las metas deben construirse con la línea base de cada hospital y por grupo de Robson. Como ejemplo operativo, a validar por el comité técnico: reducción relativa del 15–20 % en los grupos 1 y 2a a 36 meses. Esta magnitud es consistente con lo observado en intervenciones multicomponente sobre población de bajo riesgo [10,20]. No debe interpretarse como un efecto garantizado.

12.2 Gobernanza

- **Comité Técnico Interinstitucional de la CDMX.** Lo integran SEDESA/IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, INPer, universidades (UNAM, IPN), CONAMED, CDHCM como observadora y representantes de usuarias. Presidencia rotativa y sesiones mensuales.
- **Comité hospitalario de calidad obstétrica.** Lo forman jefatura de GO, enfermería obstétrica/partería, anestesiología, neonatología, epidemiología y calidad. Hay un «campeón clínico» médico y otro de enfermería.
- **Marco conceptual de implementación.** Se usará CFIR para el diagnóstico de barreras [70] y ciclos PDSA para la mejora [71].

12.3 Componentes del programa (paquete de cambio)

#	Componente	Actividades clave	Base
1	Sistema de información Robson	Formato Robson en el expediente o partograma. Captura diaria. Tablero mensual por hospital y por grupo. Conciliación con el SINAC. Indicadores públicos agregados.	8,22
2	Auditoría con retroalimentación	Revisión mensual de las cesáreas de los grupos 1, 2 y 5 con criterios estandarizados: ¿indicada?, ¿evitable?, ¿cumplió criterios de detención? Retroalimentación individual confidencial y grupal. Enfoque de cultura justa.	9,10
3	Segunda opinión	Toda cesárea no urgente requiere la valoración de un segundo médico adscrito, documentada en una lista de verificación. Se excluyen las urgencias de categoría 1.	11
4	Protocolo de vigilancia del trabajo de parto	Adoptar la Guía de Atención del Trabajo de Parto de la OMS o un partograma con fase activa desde 5 cm. Admisión en fase activa con manejo ambulatorio o en sala de espera de la fase latente. Criterios de detención ACOG/SMFM. Auscultación intermitente en bajo riesgo. Libertad de movimiento y posición. Analgesia disponible.	14,16,17,24,66
5	Acompañamiento continuo	Acompañante de elección. Adecuaciones de privacidad con cortinas o cubículos. Voluntariado y doulas comunitarias capacitadas donde sea posible.	12
6	Equipo colaborativo con partería y enfermería obstétrica	Atención del bajo riesgo por enfermería obstétrica o partería, con el médico disponible. Ampliar el modelo de salas LPR a un hospital piloto por institución. Gestionar plazas conforme a la NOM-020.	13,26,65
7	Clínica de TOLAC y versión cefálica externa (2.º y 3.er nivel)	Consulta a las 32–36 semanas para toda mujer con una cesárea previa o con presentación pélvica. Ayuda de decisión y consentimiento. Protocolo de oxitocina y monitoreo para TOLAC.	18,19,23
8	Educación prenatal y consentimiento	Talleres en el primer nivel. Información sobre riesgos de la cesárea. Consejería ante el miedo al parto y la solicitud materna. Consentimiento conforme a la NOM-004.	44,49,56,62
9	Formación y simulación	Curso para adscritos y residentes: Robson, fisiología, distocias, parto instrumentado, versión cefálica externa, auscultación intermitente y trato digno. Simulacros trimestrales. Convenios con la Facultad de Medicina y la ENEO de la UNAM.	30,57,59

#	Componente	Actividades clave	Base
10	Colaborativo y comunicación	Sesiones de aprendizaje trimestrales entre hospitales. Reconocimiento no monetario. Campaña de información a usuarias. Coordinación con la CONAMED para guías de práctica defensible.	20,21

12.4 Fases y cronograma (36 meses)

Actividad	M1–6	M7–12	M13–18	M19–24	M25–30	M31–36
Fase 0. Instalación del comité, línea base Robson retrospectiva (12 meses previos), diagnóstico CFIR, costeo	■					
Fase 1. Piloto en 4–6 hospitales (uno por institución): componentes 1–5, 8 y 9		■	■			
Componentes 6 y 7 (partería y TOLAC/VCE) en hospitales piloto con capacidad			■	■		
Fase 2. Escalamiento escalonado al resto de hospitales (*stepped-wedge*)				■	■	■
Sesiones del colaborativo, PDSA, tablero		■	■	■	■	■
Evaluación intermedia y final; informe público			■			■

12.5 Indicadores

Tipo	Indicador (definición operativa)	Fuente / periodicidad
Resultado principal	Tasa de cesárea en los grupos 1, 2a y 2b de Robson. Tamaño relativo y contribución de cada grupo a la tasa global.	Formato Robson / mensual
Resultado	Tasa global (descriptiva). Cesárea NTSV. TOLAC ofrecida y TOLAC exitosa en el grupo 5. Versión cefálica externa ofrecida y exitosa. Parto vaginal espontáneo.	Expediente, SINAC / mensual
Proceso	Porcentaje de partogramas o Guías de la OMS completos. Cesáreas con segunda opinión documentada. Porcentaje de mujeres con acompañante. Auscultación intermitente en bajo riesgo. Consentimiento informado completo. Personal capacitado.	Auditoría por muestreo / mensual
Balance (seguridad)	Apgar <7 a los 5 min. Ingreso a UCIN de recién nacidos a término. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Muerte perinatal. Rotura uterina. Hemorragia obstétrica grave y transfusión. Desgarros de 3.er y 4.º grado. Infección. Morbilidad materna extrema. Muerte materna.	Vigilancia epidemiológica / mensual
Experiencia	Satisfacción. Percepción de trato respetuoso. Reportes de maltrato o de procedimientos no consentidos.	Encuesta breve al egreso / trimestral
Equidad	Indicadores desagregados por edad (adolescentes), lengua indígena y seguridad social.	SINAC / semestral

12.6 Evaluación

Diseño escalonado por conglomerados (*stepped-wedge*). Todos los hospitales reciben la intervención, en momentos asignados al azar. Esto resuelve el dilema ético de excluir hospitales y la limitación operativa de no poder implementar en todos a la vez [72]. El análisis complementario será de series de tiempo interrumpidas con datos del SINAC, más una evaluación de costos (costo por cesárea evitada) y otra de proceso (fidelidad, adopción). El protocolo debe registrarse y someterse a comités de ética e investigación institucionales.

12.7 Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Retraso de cesáreas indicadas por presión de metas	Indicadores de balance con umbrales de alerta. Metas solo por grupo de Robson. Revisión de eventos centinela. Comunicar que la cesárea indicada es un éxito.
Resistencia del personal y temor médico-legal	Participación desde el diseño. Protocolos institucionales firmados por la dirección como respaldo. Diálogo con la CONAMED. Documentación estandarizada.
Saturación de salas de labor	Áreas de fase latente. Admisión en fase activa. Redistribución de bajo riesgo hacia hospitales con capacidad. Priorizar componentes de bajo costo.
Calidad del dato o manipulación de la clasificación	Validación cruzada con el SINAC. Auditoría externa de una muestra. Capacitación en Robson.
Rotación de directivos o cambios administrativos	Lineamiento formal publicado. Inclusión en programas sectoriales. Comité con representación técnica estable.
Conflictos por la NOM-020 y el alcance de la partería	Definir protocolos de referencia y alcances conjuntos. Diálogo intercultural. Empezar con partería profesional y enfermería obstétrica ya contratadas.

13. Viabilidad

Dimensión	Valoración	Justificación
Normativa	**Alta**	NOM-007, NOM-004, GPC 048 y 052-19, reforma de partería y NOM-020, modelo humanizado y leyes de violencia obstétrica dan sustento suficiente [22–26,28,49,51].
Técnica	**Alta**	Hay herramientas de la OMS estandarizadas [8,16] y la intervención de segunda opinión ya se probó en México [11].
Financiera	**Media**	Los componentes 1–5 y 8–10 son de bajo costo. Los componentes 6 y 7 requieren plazas e infraestructura. Las cesáreas evitadas liberan quirófano, días-cama y costos de complicaciones [47,48].
Organizacional	**Media**	Fragmentación institucional y saturación de los hospitales de referencia, frente a la experiencia previa con AMIIMSS y con las salas LPR de SEDESA [39,69].
Política y social	**Media-alta**	Agenda de derechos humanos activa [27,52] y estrategia nacional de partería [50,61]. Publicar tasas por hospital es políticamente sensible.
Cultural (profesional y usuarias)	**Media-baja**	La normalización de la cesárea durante décadas [1,33] exige trabajo sostenido de formación y comunicación.

14. Vacíos de evidencia y agenda de investigación

- No hay una serie oficial publicada de cesáreas por institución y por grupo de Robson para la CDMX. Es prioritaria para la línea base.
- Faltan evaluaciones independientes de AMIIMSS y de las salas LPR de SEDESA.
- Faltan ensayos sobre incentivos financieros, publicación de tasas y líderes de opinión, según la revisión Cochrane [62].
- Falta evidencia sobre la continuidad con partería en países de ingreso medio y en mujeres con riesgo social [13,30].
- Falta medir el efecto de la práctica dual público-privada y de la medicina defensiva sobre la decisión de cesárea en México.
- Faltan evaluaciones del impacto de la NOM-020-SSA-2025 en la cobertura y en los resultados.

15. Conclusiones

El exceso de cesáreas en México es persistente y multicausal, y la CDMX no es la excepción. En los hospitales públicos de la ciudad existen condiciones normativas y técnicas para reducirlo de manera segura. Ninguna intervención aislada basta. La evidencia respalda un paquete multicomponente con tres ejes:

1. **Medición y rendición de cuentas clínica:** Robson, auditoría y segunda opinión.
2. **Transformación de la atención del trabajo de parto:** criterios modernos, auscultación intermitente, acompañamiento, analgesia, y partería o enfermería obstétrica.
3. **Capacidades y confianza:** formación y simulación, clínicas de TOLAC y versión cefálica externa, consentimiento y decisión compartida, y diálogo médico-legal.

El paquete debe acompañarse de indicadores de seguridad y de un enfoque de derechos [9,30]. La meta no es una cifra, sino que cada cesárea esté indicada, sea oportuna y esté consentida, y que cada parto vaginal sea seguro y respetado.

Glosario de siglas

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists · AMIIMSS: Atención Materna Integral IMSS · CDHCM: Comisión de Derechos Humanos de la CDMX · CFIR: Consolidated Framework for Implementation Research · CMQCC: California Maternal Quality Care Collaborative · CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos · CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico · DGIS: Dirección General de Información en Salud · ECA: ensayo clínico aleatorizado · ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica · ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares · GPC: Guía de Práctica Clínica · LPR: labor-parto-recuperación · NTSV: nulípara, término, feto único, cefálico · PDSA: planificar-hacer-estudiar-actuar · PUEM: Plan Único de Especializaciones Médicas · SEDESA: Secretaría de Salud de la CDMX · SINAC: Subsistema de Información sobre Nacimientos · TOLAC: prueba de trabajo de parto después de cesárea · VCE: versión cefálica externa.

Referencias

1. Uribe-Leitz T, Barrero-Castillero A, Cervantes-Trejo A, Santos JM, de la Rosa-Rabago A, Lipsitz SR, et al. Trends of caesarean delivery from 2008 to 2017, Mexico. Bull World Health Organ. 2019;97(7):502-12. doi:10.2471/BLT.18.224303.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. Nota técnica y principales resultados. Aguascalientes: INEGI; 2024. Resumen estatal: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Principales resultados de la ENADID 2023 (Parte I); 2024.

3. Reportaje N+ (nmas.com.mx). El negocio de nacer: México y la epidemia de cesáreas [Internet]. Análisis de bases de datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS/SINAC), Secretaría de Salud. Fuente periodística secundaria; cifras pendientes de verificación en los cubos SINAC.
4. Instituto Nacional de Salud Pública. The impact of excessive caesarean deliveries on gestational age at birth in Mexico: national-level trends, 2010-2023 (difusión institucional). Reportado en: Crónica. Aumentan las cesáreas en México: los riesgos de las cirugías innecesarias. 30 ago 2026.
5. World Health Organization. WHO statement on caesarean section rates. Geneva: WHO; 2015 (WHO/RHR/15.02). Publicado también en: Betrán AP, Torloni MR, Zhang JJ, Gülmezoglu AM; WHO Working Group on Caesarean Section. BJOG. 2016;123(5):667-70.
6. Sandall J, Tribe RM, Avery L, Mola G, Visser GH, Homer CS, et al. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. Lancet. 2018;392(10155):1349-57.
7. Gobierno de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno. Atiende SEDESA más de 24 mil nacimientos de manera gratuita en 2022 [comunicado]. Ciudad de México; 2023.
8. World Health Organization. Robson Classification: Implementation Manual. Geneva: WHO; 2017. ISBN 9789241513197.
9. World Health Organization. WHO recommendations: non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. Geneva: WHO; 2018. ISBN 9789241550338.
10. Chaillet N, Dumont A, Abrahamowicz M, Pasquier JC, Audibert F, Monnier P, et al. A cluster-randomized trial to reduce cesarean delivery rates in Quebec (QUARISMA). N Engl J Med. 2015;372(18):1710-21.
11. Althabe F, Belizán JM, Villar J, Alexander S, Bergel E, Ramos S, et al. Mandatory second opinion to reduce rates of unnecessary caesarean sections in Latin America: a cluster randomised controlled trial. Lancet. 2004;363(9425):1934-40.
12. Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD003766. doi:10.1002/14651858.CD003766.pub6.
13. Sandall J, Fernandez Turienzo C, Devane D, Soltani H, Gillespie P, Gates S, et al. Midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev. 2024;4:CD004667. doi:10.1002/14651858.CD004667.pub6.
14. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus No. 1: Safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2014;123(3):693-711.
15. World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO; 2018.
16. World Health Organization. WHO Labour Care Guide: user's manual. Geneva: WHO; 2020.
17. Alfirevic Z, Devane D, Gyte GML, Cuthbert A. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2:CD006066. doi:10.1002/14651858.CD006066.pub3.
18. Hofmeyr GJ, Kulier R, West HM. External cephalic version for breech presentation at term. Cochrane Database Syst Rev. 2015;4:CD000083. doi:10.1002/14651858.CD000083.pub3.
19. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 205: Vaginal birth after cesarean delivery. Obstet Gynecol. 2019;133(2):e110-27.
20. Rosenstein MG, Chang SC, Sakowski C, Markow C, Teleki S, Lang L, et al. Hospital quality improvement interventions, statewide policy initiatives, and rates of cesarean delivery for nulliparous, term, singleton, vertex births in California. JAMA. 2021;325(16):1631-9.
21. Ayres-de-Campos D, et al. Lowered national cesarean section rates after a concerted action. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015. doi:10.1111/aogs.12582.
22. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016.
23. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). Guía de Práctica Clínica: Reducción de la frecuencia de operación cesárea. IMSS-048-08. México: Secretaría de Salud.
24. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. GPC-IMSS-052-19. Actualización 2019. México: Secretaría de Salud; 2019.
25. Cámara de Diputados. Publica DOF reformas para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de la partería tradicional (Decreto que reforma la Ley General de Salud, DOF 26 de marzo de 2024) [Notilegis].
26. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, relativa a establecimientos y servicios de partería para la atención integral materna y neonatal. Diario Oficial de la Federación, 4 de marzo de 2025 (entrada en vigor: 31 de agosto de 2025).
27. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. México: CNDH; 31 de julio de 2017.
28. Congreso de la Ciudad de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 6, fracción VII (violencia obstétrica); reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX (10 jun 2022 y posteriores). Compilación del Poder Judicial de la CDMX, 2025.
29. Betran AP, Ye J, Moller AB, Souza JP, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. BMJ Glob Health. 2021;6(6):e005671. doi:10.1136/bmjgh-2021-005671.
30. Betrán AP, Temmerman M, Kingdon C, Mohiddin A, Opiyo N, Torloni MR, et al. Interventions to reduce unnecessary caesarean sections in healthy women and babies. Lancet. 2018;392(10155):1358-68.
31. Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys. Lancet Glob Health. 2015;3(5):e260-70.
32. Boerma T, Ronsmans C, Melesse DY, Barros AJD, Barros FC, Juan L, et al. Global epidemiology of use of and disparities in caesarean sections. Lancet. 2018;392(10155):1341-8.
33. Puentes-Rosas E, Gómez-Dantés O, Garrido-Latorre F. Las cesáreas en México: tendencias, niveles y factores asociados. Salud Publica Mex. 2004;46(1):16-22.
34. González-Pérez GJ, Vega-López MG, Cabrera-Pivaral C, Muñoz A, Valle A. Caesarean sections in Mexico: are there too many? Health Policy Plan. 2001;16(1):62-7. doi:10.1093/heapol/16.1.62.
35. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Documento analítico: Cesáreas en México [Internet]. Cuernavaca: INSP; 2013. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/doctos/analiticos/Cesareas.pdf
36. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2023. Aguascalientes: INEGI; 2024.
37. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2023. Comunicado de prensa. Aguascalientes: INEGI; 2024.

38. Muñoz Hernández, Freyermuth Enciso, Ochoa Torres. [Artículo sobre el incremento de cesáreas en México, 2011-2014, y su relación con el Seguro Popular]. Población y Salud en Mesoamérica. 2020 (enero). Disponible en DOAJ: https://doaj.org/article/aa763f9bb048413e80c2e63c7eb8282f
39. Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA). Comunicados de prensa sobre atención materna gratuita, Sala de Labor-Parto-Recuperación del Hospital General Iztapalapa y servicio de partería profesional, 2023-2024 [Internet]. Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx
40. Moreno-López RJ, López-de-Silanes A, Fuentes-Astudillo ZR, Ayala-Yáñez R. Índice de Robson: riesgo de cesárea en un centro de primer nivel en México. Ginecol Obstet Mex. 2023;91(8):570-80.
41. [Estudio de las quejas médicas en ginecología y obstetricia atendidas por la CONAMED, 2001-2015]. Rev CONAMED. 2018;23(1). Disponible en: https://biblat.unam.mx/hevila/RevistaCONAMED/2018/vol23/no1/6.pdf
42. Marian et al. Association between location of prenatal care services and non-consented cesarean sections in Mexico: a secondary analysis of the National Survey on the Dynamics of Household Relationships 2016. PLoS One. 2024;19(5):e0303052. doi:10.1371/journal.pone.0303052.
43. Marian et al. Prevalence of different variations of non-consented care during the childbirth process in Mexico by geographical regions: comparing ENDIREH survey data from 2016 to 2021. BMC Pregnancy Childbirth. 2024;24:353. doi:10.1186/s12884-024-06549-1.
44. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 761: Cesarean delivery on maternal request. Obstet Gynecol. 2019;133(1):e73-7.
45. Martínez-Garrido P, Fritz J, Montoya A, Garza MJ, Lamadrid-Figueroa H. Obstetric risk profiles and causes of death: estimating their association with cesarean sections among maternal deaths in Mexico. PLoS One. 2024;19(5):e0302369.
46. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, semana epidemiológica 18 de 2024. México: SSA; 2024.
47. Gibbons L, Belizán JM, Lauer JA, Betrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage. World Health Report 2010, Background Paper No. 30. Geneva: WHO; 2010.
48. Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuerdo por el que se aprueban los costos unitarios por nivel de atención médica y el tabulador para pacientes no derechohabientes (DOF, ediciones 2023-2025). Difusión: El Financiero, ¿Cuánto cuesta tener un parto en el IMSS y en el ISSSTE?, 11 feb 2023.
49. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación, 15 de octubre de 2012.
50. Secretaría de Salud. ACUERDO por el que se establece el Comité Nacional de Partería. Diario Oficial de la Federación, 1 de mayo de 2026.
51. Secretaría de Salud (CNEGSR/DGPLADES). Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro; y Lineamientos/Guía para su implantación [Internet]. México: Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx
52. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Informe anual 2023, Volumen II: Violencia obstétrica en la Ciudad de México: avances y retos. Ciudad de México: CDHCM; 2024.
53. International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). FIGO statement on caesarean section. London: FIGO; 2007.
54. FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health. Ethical aspects regarding cesarean delivery for non-medical reasons. Int J Gynaecol Obstet. 1999;64(3):317-22.
55. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. New York: Oxford University Press; 2019.
56. Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361-7.
57. Facultad de Medicina, UNAM. Plan de Estudios 2010 y programas académicos de la Licenciatura de Médico Cirujano; Programa de la asignatura Ginecología y Obstetricia (4.º año, 8.º semestre) 2026 y Programa de Internado Médico (5.º año). Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social [Internet]. Disponible en: https://seciss.facmed.unam.mx
58. Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Programa operativo de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, Hospital General Dr. Enrique Cabrera (aval UNAM, basado en el Plan Único de Especializaciones Médicas) [Internet]. Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx
59. Simulation-based teaching for instrumental delivery with forceps: a systematic scoping review. Revista Española de Educación Médica (Universidad de Murcia). Disponible en: https://revistas.um.es/edumed/article/view/639081
60. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM. Proyecto de modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Tomo I (2022) y Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 [Internet]. Disponible en: https://enfermeria.unam.mx
61. La Razón de México. Con parteras, a prueba nuevo modelo de salud. 10 ago 2026 (cifras institucionales de IMSS e IMSS-Bienestar sobre plazas y matronas).
62. Chen I, Opiyo N, Tavender E, Mortazhejri S, Rader T, Petkovic J, et al. Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2018;9:CD005528. doi:10.1002/14651858.CD005528.pub3.
63. An implementation analysis of a quality improvement project to reduce cesarean section in Brazilian private hospitals (Projeto Parto Adequado). Reprod Health. 2024. doi:10.1186/s12978-024-01773-6.
64. Lotfi R, et al. The impact of Health Transformation Plan on natural vaginal delivery and cesarean section frequency in Iran: an interrupted time series analysis. BMC Res Notes. 2021. (PMC8254991).
65. Birthplace in England Collaborative Group (Brocklehurst P, et al.). Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ. 2011;343:d7400.
66. Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A. Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev. 2018;5:CD000331. doi:10.1002/14651858.CD000331.pub4.
67. National Institutes of Health Consensus Development Conference Panel. National Institutes of Health Consensus Development conference statement: vaginal birth after cesarean: new insights, March 8-10, 2010. NIH Consens State Sci Statements. 2010;27(3):1-42.
68. Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, Tita ATN, Silver RM, Mallett G, et al. Labor induction versus expectant management in low-risk nulliparous women (ARRIVE). N Engl J Med. 2018;379(6):513-23.
69. Instituto Mexicano del Seguro Social. Boletines de prensa sobre el modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), núms. 003, 058 y 233 de 2024 [Internet]. Ciudad de México: IMSS; 2024.

70. Damschroder LJ, Aron DC, Keith RE, Kirsh SR, Alexander JA, Lowery JC. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. Implement Sci. 2009;4:50.
71. Langley GJ, Moen RD, Nolan KM, Nolan TW, Norman CL, Provost LP. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2009.
72. Hemming K, Haines TP, Chilton PJ, Girling AJ, Lilford RJ. The stepped wedge cluster randomised trial: rationale, design, analysis, and reporting. BMJ. 2015;350:h391.